

Mirror Soul

Reporte generado por IA

Paciente: 4

Sesión: 266

Fecha: Thu Aug 06 2026 23:20:21 GMT-0600 (hora estándar central)

Contenido

Reporte Final Preliminar - Evaluación Psicológica

****Paciente:**** Luci

****Edad:**** 11 años

****Género:**** Femenino

1. Resumen Clínico Breve

Luci, una paciente de 11 años de edad que cursa la primaria, presenta antecedentes emocionales de depresión. Su historial inicial reporta como evaluación principal "depresión" y una impresión diagnóstica inicial de "ansiedad pero faltan pruebas", lo que sugiere una posible comorbilidad o la necesidad de diferenciar entre ambas presentaciones. Se observa el hábito de morderse los labios. A nivel médico, se mencionan antecedentes de rinitis, cálculos renales y una fractura de codo, además de estar actualmente medicada con metformina e histofil. Su desarrollo cognitivo y escolar ha sido reportado como bueno y sin dificultades significativas.

2. Patrones Observados en Pruebas y Notas

* ****Ausencia de Pruebas Concluyentes:**** La nota "realizar pruebas" y la indicación de que "no se registraron pruebas en esta sesión" resaltan la falta de datos psicométricos objetivos. Esto impide la cuantificación y cualificación de la sintomatología actual, así como la diferenciación clara entre los estados de depresión y ansiedad mencionados.

* ****Discrepancia/Necesidad de Clarificación Diagnóstica:**** La coexistencia de "depresión" como antecedente y evaluación inicial, junto con una "ansiedad" como diagnóstico inicial pendiente de pruebas, subraya la necesidad de una exploración detallada para determinar el cuadro clínico predominante, la comorbilidad o si se trata de una presentación atípica.

* ****Signos de Tensión/Ansiedad:**** El hábito de "morderse los labios" podría ser un indicador conductual de ansiedad, estrés o tensión emocional que requiere mayor indagación.

* ****Relevancia de la Medicación:**** El uso de metformina en una paciente de 11 años es un hallazgo clínico que merece mayor investigación en el contexto psicológico. Es fundamental comprender el diagnóstico médico subyacente que justifica este medicamento y evaluar si existen efectos secundarios o comorbilidades físicas que puedan impactar su estado de ánimo o funcionamiento cognitivo.

3. Riesgos Detectados

* ****Riesgo de Subdiagnóstico o Diagnóstico Incompleto:**** La falta de pruebas psicológicas y la ambigüedad entre los diagnósticos iniciales conllevan el riesgo de no abordar adecuadamente la problemática emocional subyacente.

* ****Riesgo de Recaída/Agravamiento de Sintomatología:**** Dada la historia de depresión, sin una evaluación actual completa, existe el riesgo de que la sintomatología pueda recurrir o intensificarse sin intervención adecuada.

* ****Riesgo Asociado a Comorbilidades Médicas:**** La medicación y los antecedentes médicos deben ser considerados en la evaluación psicológica, ya que podrían influir en el estado anímico, la energía o la

respuesta al tratamiento.

4. Recomendaciones de Seguimiento

1. ****Aplicación de Batería de Pruebas Psicológicas:**** Administrar instrumentos estandarizados para evaluar sintomatología depresiva (ej. CDI, BDI-II adaptado para niños), de ansiedad (ej. MASC-2, SCARED), y una evaluación general del funcionamiento socioemocional y cognitivo.
2. ****Anamnesis Detallada:**** Profundizar en la historia de la depresión (edad de inicio, desencadenantes, duración, intensidad, impacto funcional) y la manifestación de la ansiedad.
3. ****Exploración del Hábito:**** Indagar sobre la frecuencia, contexto y función del hábito de morderse los labios.
4. ****Coordinación Interdisciplinaria:**** Contactar al médico tratante para aclarar el motivo del uso de metformina e histofil, así como cualquier diagnóstico médico relevante que pueda influir en su bienestar psicológico.
5. ****Observación Conductual Continua:**** Mantener un registro de cambios en el estado de ánimo, patrones de sueño, apetito, rendimiento escolar e interacciones sociales.

5. Observaciones sobre Multimedia

No se proporcionó ni se observó material multimedia durante la sesión o en el expediente.

6. Nota Aclaratoria

Este reporte es preliminar y se basa en la información disponible hasta el momento. No constituye un diagnóstico definitivo y se requiere una evaluación más profunda, incluyendo la administración de pruebas psicológicas y una anamnesis exhaustiva, para establecer un plan de tratamiento adecuado.